UE D1.1 · SEMESTRE 1 · TD1 DU 20 OCTOBRE 2026

LA COMMUNICATION

Fiche de révision écrite

Support du TD et notes de cours

Pourquoi cette fiche ?

Comprendre la communication soignant-soigné, puis **analyser une situation concrète** : repérer un besoin, identifier ce qui facilite ou empêche l'échange, et proposer un ajustement professionnel.

Objectifs expressément inscrits dans le TD

- Communiquer clairement, avec respect et sans stigmatisation, auprès de la personne et de son entourage.
- Identifier les principes de la communication dans les soins infirmiers.
- Différencier verbal et non verbal, en comprenant le rôle du paraverbal.
- Reconnaître les attitudes facilitantes et les obstacles.

Lecture à deux niveaux

Essentiel : la notion à mémoriser pour savoir la définir.

Pour comprendre : les explications, mécanismes et nuances.

En pratique : une application à une situation de soin.

Note de cours : une précision utile apportée en séance.

Une seule démarche : 5 étapes pour analyser un échange

Étape	Réflexe à mémoriser
1 · Décrire	Quels faits verbaux, non verbaux et contextuels observe-t-on ?
2 · Identifier	Quel besoin, obstacle ou décalage est en jeu ?
3 · Hypothétiser	Quelles conséquences sont possibles, sans les affirmer ?
4 · Ajuster	Quelle action concrète le soignant peut-il proposer ?
5 · Vérifier	Quel retour permet de savoir si l'ajustement fonctionne ?

Sommaire rapide — accès direct aux chapitres

Fondamentaux et canaux p. 2–5
Adapter à la personne p. 6–9
Obstacles et relations p. 10–12
Méthode d'analyse p. 13
Situations comparatives p. 14
À retenir p. 15
Pièges QCM p. 16
Synthèse générale p. 17
Définitions et mots-clés p. 18–19

Réflexe de partiel

Dans une vignette clinique, répondre en trois temps : **ce que j'observe**, **ce que cela peut produire**, **ce que le soignant peut faire autrement**. Les conséquences restent des hypothèses tant que la situation ne les confirme pas.

01 Définir la communication

ESSENTIEL

Communiquer n'est pas seulement parler : c'est entrer en relation, transmettre et partager un message dont le sens est interprété par l'autre.

POUR COMPRENDRE

Le TD définit la communication comme un **processus cognitif, social et affectif** entre plusieurs personnes. Elle sert à transmettre une information, une émotion, une demande, à convaincre ou à susciter une action. Une personne communique également sans prononcer de mots, par son regard, ses gestes, sa posture et son silence.

Parler et communiquer : une distinction à maîtriser

Parler	Communiquer
Émettre des mots ou sons articulés pour exprimer une pensée.	Établir un échange avec un interlocuteur, y compris sans mots.
Un discours peut rester à sens unique.	Le message reçoit une signification chez le destinataire.
Dire une information ne garantit pas qu'elle a été comprise.	Observer la réception et chercher un retour fait partie de l'échange.

Le circuit de communication

Élément	Fonction	Ce qui peut perturber
Émetteur	Produit le message.	Émotions, formulation, attitudes, crédibilité.
Message	Contenu et forme de l'information.	Mots techniques, imprécision, sous-entendus.
Canal	Moyen de transmission : oral, écrit, visuel…	Canal inadapté aux capacités de la personne.
Récepteur	Reçoit et interprète.	Langue, représentations, attention, sensorialité.
Feedback / rétroaction	Réaction permettant d'apprécier la réception.	Absence de vérification ou fausse interprétation du « oui ».

Application en situation de soin

Après avoir expliqué un soin, le soignant ne conclut pas automatiquement qu'il a été compris parce que le patient acquiesce. Il peut demander : « Qu'avez-vous retenu ? » ou « Souhaitez-vous que je reprenne un point ? »

02 Feedback, filtres et déformation du message

ESSENTIEL

Message émis ≠ message nécessairement compris. Le feedback permet de vérifier et d'ajuster ; les filtres peuvent transformer le sens à chaque étape.

POUR COMPRENDRE

Les **filtres** sont les éléments personnels, relationnels et contextuels qui influencent la façon d'encoder, recevoir ou interpréter un message. Ils n'indiquent pas seulement une barrière de langue.

Filtre	Illustration	Réajustement professionnel
Expériences / représentations	Un soin antérieur mal vécu change les attentes.	Demander ce que la personne anticipe ou redoute.
Émotions	Peur, colère, anxiété, fatigue.	Accueillir le ressenti ; adapter le moment et le rythme.
Croyances / valeurs	Interprétations, convictions et habitudes différentes.	Écouter sans jugement ni interprétation hâtive.
Contexte social	Hiérarchie, codes culturels, sentiment d'infériorité.	Adopter des mots et une posture respectueux.
Environnement	Bruit, interruptions, absence d'intimité.	Modifier le lieu ou réduire les perturbateurs.

Limiter les déformations à trois moments

- **Avant :** préciser le but du message, anticiper le vocabulaire et le canal.
- **Pendant :** tenir compte des émotions, de l'attention, de la tonalité et du confort.
- **Après :** demander un retour, identifier l'incompréhension et reprendre différemment.

Note de cours

L'intervenante met en garde contre les **transmissions teintées de jugements** : un qualificatif péjoratif transmis entre collègues peut créer un a priori avant même de rencontrer la personne. Distinguer un fait observable d'une interprétation.

03 Verbal, paraverbal et non verbal

ESSENTIEL

La forme du message participe à son sens : les mots, la voix et l'attitude corporelle doivent être considérés ensemble.

Modalité	Contenu	Exemple soignant
Verbale	Mots, vocabulaire, formulation et sens explicite.	« Je vais vous expliquer ce soin étape par étape. »
Paraverbale	Intonation, volume, débit, timbre, pauses, prosodie.	Parler plus lentement pour laisser le temps de comprendre.
Non verbale	Regard, mimiques, visage, posture, gestes, distance, présentation de soi.	Se mettre dans une position permettant le contact et l'écoute.

Les cinq domaines regroupés dans le support

- **Territoire / proxémie :** place occupée, distance et respect de l'espace intime.
- **Posture et gestuelle :** orientation du corps, tonus, mouvements, contact physique.
- **Image corporelle :** apparence et présentation de soi, interprétées dans un cadre culturel.
- **Visage et mimiques :** expressions et réactions qui renseignent sur le vécu.
- **Voix :** ton et rythme ; sur le plan analytique, ce domaine relève du paraverbal.

POUR COMPRENDRE

Le support insiste sur l'importance de la concordance des signaux. Un ton pressé, une posture fermée ou un regard absent peuvent contredire des mots rassurants. La signification d'un geste dépend du contexte et de la personne ; aucun signe isolé ne suffit à conclure.

Chiffres du support : prudence d'interprétation

Le support cite la répartition **7 / 38 / 55** attribuée à Mehrabian. Ces proportions ne doivent pas être présentées comme une loi universelle de toute communication. Leur portée exacte n'est pas établie par les documents disponibles ; garder cette réserve pour les révisions.

04 Congruence, proxémie et juste distance

ESSENTIEL

La **congruence** est la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on laisse paraître. La juste distance permet une relation de confiance sans imposer une familiarité.

POUR COMPRENDRE

Dire « je suis disponible » tout en poursuivant une autre activité sans regarder la personne peut envoyer un message contradictoire. Les paroles, la prosodie et l'attitude doivent traduire une attention réelle.

Note de cours

L'intervenante revient sur la congruence comme un repère essentiel du soin relationnel : **ce que je dis et ce que je renvoie doivent être en accord**. Elle insiste aussi sur le « je » pour marquer un engagement personnel plutôt qu'un « on » imprécis.

Trois notions proches mais différentes

Notion	À comprendre	À faire en soin
Congruence	Accord entre paroles et attitude.	Se rendre effectivement disponible lorsqu'on propose d'écouter.
Proxémie	Gestion de l'espace et de la distance physique.	Adapter la proximité et ne pas envahir l'espace intime.
Juste distance	Équilibre relationnel entre proximité aidante et cadre professionnel.	Éviter l'infantilisation, les familiarités imposées et la posture dominante.

Bâtir la confiance : des comportements observables

- Se présenter, rendre son rôle identifiable et respecter l'appellation souhaitée.
- Être attentif à la dignité, à l'intimité et aux paroles de la personne.
- Ne pas inventer une réponse lorsqu'on ne sait pas : se renseigner.
- Tenir les engagements annoncés ; un « je reviens » implique une action.
- Respecter les préférences de la personne sans supposer une familiarité autorisée.

Application en situation de soin

Au lieu de « On verra plus tard », expliquer : « Je n'ai pas cette information pour le moment ; je vais me renseigner et revenir vers vous. » Cette formule n'est pertinente que si l'engagement peut être tenu.

05 Adapter la communication à la personne

ESSENTIEL

Le préalable explicitement souligné en séance est de **chercher les besoins et les demandes** de la personne avant de choisir quoi dire et comment le dire.

POUR COMPRENDRE

Une communication est adaptée lorsqu'elle tient compte des attentes, du niveau de compréhension, de la réceptivité et du contexte. Le même message ne sera pas forcément formulé de la même manière selon la fatigue, les capacités sensorielles, les émotions ou l'entourage.

Avant d'expliquer, repérer…	Pourquoi cela compte
Besoins, demandes et attentes	Éviter une réponse décalée par rapport à la préoccupation réelle.
Capacités cognitives et mémorisation	Moduler les étapes, les répétitions et le rythme.
Sens, langage et expression	Choisir une modalité compréhensible et accessible.
État émotionnel	Ne pas prendre un silence ou une inquiétude pour de l'indifférence.
Choix, autonomie et préférences	Permettre à la personne de rester actrice de son soin.
Lieu, temps, positions et entourage	Créer des conditions favorables et respecter la confidentialité.

Une méthode simple au moment de parler

- Employer une phrase claire et des mots accessibles ; expliquer en étapes.
- Respecter le délai de réception et les silences : ne pas exiger une réponse immédiate.
- Observer le regard, le visage et la posture sans surinterpréter.
- Chercher un feedback : demander ce qui a été compris et reformuler si nécessaire.
- Changer le canal ou reprendre plus tard lorsqu'un échange ne fonctionne pas.

Note de cours

L'intervenante rappelle qu'une personne peut avoir besoin de **plusieurs explications** pour mémoriser. Répéter ou reformuler avec patience n'est pas une faveur mais une adaptation à ses capacités.

06 Autonomie, choix et refus dans le soin

ESSENTIEL

Communiquer ne consiste pas à obtenir mécaniquement un « oui ». Le soignant recherche la participation de la personne et prend en compte ses choix et réticences.

POUR COMPRENDRE

Dans le TD, l'exemple de la toilette illustre ce principe : si la personne ne souhaite pas ce soin au moment proposé, le professionnel ne se contente pas de donner un ordre. Il explore les raisons, écoute et cherche un ajustement selon le contexte de prise en charge.

Situation	Posture inadaptée	Posture professionnelle possible
Personne qui ne veut pas sa toilette maintenant	Imposer le moment sans échange.	Demander ce qui gêne et envisager une adaptation.
Personne encore capable de réaliser des gestes	Faire immédiatement l'ensemble du soin à sa place.	Demander ce qu'elle peut et souhaite faire elle-même.
Personne qui paraît passive	Supposer qu'elle consent ou comprend tout.	Lui laisser du temps, proposer des choix et vérifier la compréhension.

Note de cours

En séance, l'intervenante attire l'attention sur les soins faits **à la place** du patient par habitude ou manque de temps. Ce comportement peut diminuer sa participation. Il faut reconnaître les capacités préservées et favoriser l'autonomie sans imposer une performance.

Application en situation de soin

Une personne refuse momentanément la toilette : « Qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui ? Préférez-vous qu'on en parle et qu'on voie ensemble comment s'organiser ? »

Limite de cette fiche

Cette fiche porte sur la **communication dans les soins** ; elle ne remplace pas le cours de droit relatif aux modalités juridiques du consentement et du refus.

07 Entourage et communication alternative

ESSENTIEL

La relation de soin peut associer des proches, mais les besoins et la parole de la personne soignée restent le point de départ de la communication.

POUR COMPRENDRE

Les familles peuvent être inquiètes, demander de nombreuses explications ou exprimer des vues différentes de celles du patient. Elles peuvent aussi apporter des informations précieuses sur son fonctionnement habituel. Le soignant accueille leurs préoccupations tout en restant attentif à la confidentialité et au choix de la personne concernée.

Note de cours

L'intervenante précise qu'on ne communique pas seulement avec un patient isolé : l'entourage, parfois stressé ou en désaccord, fait aussi partie des situations relationnelles rencontrées. Il ne doit cependant pas effacer la parole du patient.

Si la parole ne suffit pas, adapter le canal

Difficulté	Piste évoquée dans le TD	Point de vigilance
Expression verbale limitée	Écriture, dessin, pictogrammes disponibles.	Vérifier que le support est accessible et compris.
Difficulté liée à la langue	Aide à la traduction appropriée selon les moyens du service.	Ne pas supposer qu'une traduction approximative suffit.
Émotions fortes	Écoute, délai de réponse et possibilité de reprendre.	Éviter de parler sans laisser le temps de réagir.
Vocabulaire médical opaque	Explication simple, exemples et feedback.	Simplifier sans infantiliser ni déformer le contenu.

Application en situation de soin

Une personne a du mal à exprimer une douleur à l'oral. Le soignant cherche un autre moyen de communication adapté, puis vérifie avec elle le sens de ce qui a été indiqué.

08 Écoute active, empathie et attitudes aidantes

ESSENTIEL

Les attitudes facilitantes sont **disponibilité, écoute, empathie, authenticité, non-jugement, objectivité, reformulation et respect des silences**.

Attitude	Manifestation concrète en soin
Écoute active	Laisser s'exprimer, questionner pour comprendre, observer et ne pas interrompre inutilement.
Empathie	Comprendre ce que ressent l'autre sans absorber soi-même son émotion.
Authenticité	Dire ce que l'on sait et reconnaître ses limites ; ne pas inventer.
Non-jugement / tolérance	Respecter l'histoire, la culture et les préférences sans réduire la personne à un stéréotype.
Objectivité	Décrire les faits observés plutôt qu'attribuer d'emblée des intentions.
Reformulation	Restituer avec d'autres mots le sens supposé du propos pour le vérifier.
Respect des silences	Laisser le temps de réfléchir, d'exprimer une émotion ou de répondre.
Juste présence	Être disponible sans imposer la proximité ou la conversation.

Ce qu'apporte la distinction entre empathie et sympathie

POUR COMPRENDRE

Comprendre la peine du patient n'exige pas de partager sa détresse au point de perdre sa position professionnelle. L'empathie soutient l'écoute ; elle ne signifie ni fusion émotionnelle ni familiarité. La distance professionnelle n'est pas l'indifférence.

Note de cours

L'intervenante formule l'idée ainsi : comprendre ce que ressent l'autre **sans l'absorber**. Elle rattache cette attitude à l'écoute active et au soutien, qui ne se résument pas à donner immédiatement une solution.

09 Obstacles et réajustements

ESSENTIEL

Un obstacle peut venir du **message**, de l'**attitude soignante** ou des **conditions de l'échange**. Le bon réflexe est d'identifier ce qui bloque et de réajuster.

Obstacle	Effet possible	Réajustement
Message long ou très technique	Confusion, informations mal comprises.	Segmenter, définir les mots, vérifier le sens.
Abréviation ou sous-entendu	Interprétation erronée.	Expliciter, éviter l'implicite.
Ordres, solutions imposées	Réduction de la participation.	Explorer les besoins et les ressources propres.
Jugement, critique, banalisation	Sentiment d'incompréhension ou de dévalorisation.	Accueillir le vécu, demander plutôt que présumer.
Promesse impossible à tenir	Perte de confiance ultérieure.	Dire précisément ce qui est su ou reste à vérifier.
Absence de feedback	Erreur non détectée de compréhension.	Reformuler et obtenir un retour adapté.
Familiarité imposée / domination	Malaise ou retrait possible.	Respecter appellations, intimité et juste distance.

Pourquoi « rassurer » peut devenir inadapté

POUR COMPRENDRE

Une intention bienveillante ne suffit pas. Dire « ce n'est rien » à une personne qui exprime une peur peut **banaliser son vécu**. Il est préférable de chercher ce qui inquiète, reconnaître l'émotion et fournir uniquement des éléments fiables.

Note de cours

L'intervenante déconseille de promettre de « trouver une solution » quand cela n'est pas certain. Le professionnel peut aider la personne à explorer ses propres ressources et lui fournir une information exacte, sans faire à sa place tous les choix.

10 Environnement, confidentialité et confort

ESSENTIEL

La qualité de la communication dépend également du **lieu, du moment, du confort et de l'intimité** : ce ne sont pas des détails accessoires.

Facteur	Conséquence possible	Ajustement
Porte ouverte ou couloir	Gêne à parler d'informations personnelles.	Choisir si possible un lieu et une installation préservant l'intimité.
Sonnettes, télévision, conversations	Message interrompu ou attention distraite.	Réduire les nuisances accessibles.
Entrées et sorties répétées	Rupture du fil et sentiment d'indisponibilité.	Limiter les interruptions, prévenir les collègues si pertinent.
Odeurs, chaleur, froid	Inconfort et difficulté de concentration.	Ventiler ou adapter les conditions selon ce qui est possible.
Patient allongé, soignant éloigné	Asymétrie ou difficulté à instaurer un échange.	Repenser la position et la distance, sans imposer de proximité.
Mauvais moment / fatigue	Réceptivité réduite.	Adapter le moment ou fractionner l'explication.

POUR COMPRENDRE

La **confidentialité** concerne la protection des informations personnelles. Pour qu'une personne ose s'exprimer, les conditions concrètes de l'entretien doivent également lui offrir une discrétion et un confort suffisants.

Note de cours

Les notes orales insistent aussi sur des obstacles parfois oubliés : odeurs, température, installation inconfortable et interruptions incessantes. Ces éléments peuvent affecter autant l'expression que l'écoute.

Application en situation de soin

Une discussion sensible débute dans un couloir bruyant. Le soignant propose, si la situation le permet, de reprendre dans un lieu approprié, puis vérifie que la personne est correctement installée.

11 Les formes de relation évoquées dans le TD

ESSENTIEL

La relation de soin traverse les gestes techniques et les échanges ordinaires. Les formes de relation suivantes se distinguent par leur **finalité**, sans être forcément exclusives.

Relation	Finalité	Exemple pédagogique
Civilité	Respecter les codes de l'échange humain.	Saluer, se présenter, employer un langage respectueux.
Relation de soin	Accompagner et informer pendant la prise en charge.	Recueillir des données, expliquer un examen, faire une toilette.
Relation empathique	Comprendre le vécu et l'émotion du patient.	Accueillir son inquiétude sans la minimiser.
Aide et soutien psychologique	Soutenir la personne face à une difficulté.	Offrir un temps d'écoute et orienter si nécessaire.
Relation éducative	Favoriser compréhension et apprentissages utiles au soin.	Expliquer des conseils d'hygiène ou un traitement.
Relation thérapeutique	Utiliser la relation comme modalité de soin dans un cadre adapté.	Ateliers et médiations mentionnés en contexte psychiatrique.

Note de cours

L'intervenante rappelle que la relation de soin commence dès l'accueil, l'information et le recueil de données. Une toilette, une explication de traitement ou une écoute de la douleur sont aussi des moments relationnels.

Éviter les oppositions artificielles

Les catégories se chevauchent : une même situation peut comporter à la fois un échange de civilité, une explication éducative et une attitude empathique.

12 Méthode reproductible de raisonnement infirmier

ESSENTIEL

Pour traiter une situation de communication, relier **faits → conséquences possibles → réajustement observable**, sans inventer les émotions ou motivations du patient.

Étape	Question de raisonnement	Traduction en réponse de partiel
1. Décrire	Que voit-on et qu'entend-on ?	Nommer les faits : mots, gestes, lieu, réactions.
2. Identifier	Quel besoin, obstacle ou décalage apparaît ?	Associer la situation à une notion : filtre, congruence, feedback…
3. Hypothétiser	Quel effet relationnel est possible ?	Dire « peut », sans prétendre connaître la pensée du patient.
4. Ajuster	Que pourrait faire concrètement le soignant ?	Proposer une action : écouter, expliquer, changer le canal…
5. Vérifier	Comment sait-on si l'ajustement fonctionne ?	Observer le retour et redemander ce qui a été compris.

Mini-cas : patient qui répond seulement « oui »

Observation	Risque possible	Réajustement
Le patient dit « oui » après une explication complexe.	Le professionnel peut surestimer la compréhension.	Inviter à reformuler ou poser une question ouverte.
Le patient ne pose aucune question.	Il peut être gêné, fatigué ou avoir compris : on ne sait pas.	Laisser du temps, explorer les besoins et respecter sa réponse.

Exemple de formulation complète pour un partiel

Réponse construite : « Le message a été transmis, mais le retour ne prouve pas à lui seul la compréhension. Le soignant peut proposer de reprendre l'information autrement et demander au patient de dire ce qu'il en a retenu. »

Note de cours

L'intervenante attire l'attention sur **l'adaptation et le feedback**. La démarche ne s'arrête pas à une phrase correcte : elle inclut ce que la personne a réellement pu recevoir.

13 Situations de soin — comparer les postures

ESSENTIEL

Dans les situations d'entraînement ci-dessous, l'objectif est de comprendre pourquoi une formulation peut aider ou gêner la relation. Ces cas sont construits à partir des notions du TD ; ce ne sont pas des annales officielles.

Situation	Formulation / comportement inadapté	Réajustement expliqué
Patient inquiet	« Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. »	Explorer ce qui l'inquiète, reconnaître l'incertitude et transmettre des informations fiables.
Refus momentané de toilette	« Vous devez faire votre toilette maintenant. »	Chercher le motif, écouter le choix et discuter de possibilités adaptées.
Peur d'un médicament	« Il n'y a pas de raison d'avoir peur. »	Demander l'origine de la peur et les explications souhaitées.
Patient en colère	Répondre sèchement ou lui reprocher son ton.	Reconnaître l'émotion et rechercher le problème sous-jacent.
Difficulté à s'exprimer	Parler de plus en plus fort sans explorer la cause.	Chercher un autre canal si celui-ci est plus accessible.
Soignant préoccupé par son écran	Dire « je vous écoute » sans se rendre disponible.	Prendre un temps de face-à-face puis annoncer l'usage nécessaire de l'outil.

Ne pas confondre empathie et accord systématique

POUR COMPRENDRE

Reconnaître qu'une personne est en colère n'impose pas d'approuver tout ce qu'elle dit. La posture adaptée associe écoute, respect et cadre professionnel.

Trame utilisable en TD, stage et évaluation

Construire une réponse en trois phrases : **« J'observe que… »** (fait), **« Cela peut… »** (effet possible), puis **« Je propose… »** (action adaptée).

14 À retenir — connaissances et priorités

ATTENTES EXPLICITES DU SUPPORT

- Savoir **définir la communication** et la distinguer de l'acte de parler.
- Expliquer **émetteur, message, canal, récepteur et feedback**.
- Distinguer **verbal, paraverbal et non verbal**.
- Identifier **filtres, attitudes facilitantes et obstacles**.
- Communiquer de façon **claire, respectueuse, non stigmatisante et adaptée**.

POINTS PARTICULIÈREMENT SOULIGNÉS EN SÉANCE

- Identifier les **besoins et demandes** avant de répondre.
- Pratiquer la **congruence** et une implication personnelle sincère.
- Reconnaître ses limites et **tenir les engagements** annoncés.
- Permettre à la personne de garder une **place active** dans le soin.
- Accueillir la peur, la colère et le silence **sans jugement**.
- Vérifier la compréhension, respecter le rythme et **adapter le canal**.
- Préserver confidentialité, confort et qualité du contexte relationnel.

SAVOIR FAIRE POUR L'ÉVALUATION

Face à une vignette clinique : **décrire sans juger**, identifier les notions en jeu, expliquer les conséquences **possibles**, proposer un ajustement précis et vérifier son effet.

Ne pas confondre priorité de cours et prédiction de partiel

Ce qui est présenté comme « attendu » correspond aux objectifs annoncés par le support. Les pièges QCM qui suivent sont des points de vigilance construits pour réviser ; il ne s'agit pas de questions officielles d'examen.

15 Pièges QCM — rubrique unique

ESSENTIEL

Repérer l'affirmation trompeuse et être capable d'expliquer la rectification, sans apprendre uniquement une réponse par cœur.

Affirmation trompeuse	Rectification
« Communiquer exige de parler. »	Les attitudes, gestes, expressions et silences communiquent aussi.
« Le patient a dit oui : il a forcément compris. »	Un oui isolé ne démontre pas la compréhension ; chercher un feedback adapté.
« Il suffit de répéter la phrase exactement pareil. »	Le langage, le canal, le rythme ou le moment peuvent devoir changer.
« Les filtres sont seulement linguistiques. »	Émotions, croyances, expériences et environnement influencent aussi le message.
« La voix forte rend toujours le message plus clair. »	Le ton, le volume et le débit doivent être adaptés à la personne.
« Être empathique, c'est absorber la douleur de l'autre. »	L'empathie vise la compréhension sans fusion émotionnelle.
« La juste distance consiste à rester froid et distant. »	Être présent sans familiarité ni intrusion.
« Une intention rassurante rend toute parole acceptable. »	Banaliser le vécu ou promettre sans savoir peut nuire à la confiance.
« Il faut toujours donner immédiatement une solution. »	Explorer d'abord le besoin et soutenir les ressources du patient.
« L'entourage décide à la place de la personne. »	Sa contribution n'efface pas les souhaits et l'expression du patient.
« Un soin technique ne mobilise pas la relation de soin. »	Accueil, information, observation et adaptation interviennent aussi lors des actes.
« Des transmissions peuvent contenir des jugements personnels. »	Distinguer faits observables et interprétations.
« Une fois la réponse donnée, la communication est terminée. »	Le feedback et le réajustement font partie de la démarche.
« Tout geste non verbal a un sens universel. »	Le contexte culturel, personnel et relationnel compte.
« Les chiffres 7/38/55 décrivent tous les échanges. »	Ne pas généraliser ces proportions hors de leur contexte d'application.
« Reconnaître qu'on ne sait pas est un défaut. »	L'authenticité consiste à le dire et à rechercher l'information appropriée.

DERNIER CONTRÔLE AVANT LE PARTIEL

Dans une question de situation, privilégier une réponse justifiée par le **besoin**, la **communication adaptée** et la **vérification de la compréhension**, plutôt qu'une formule automatique.

SYNTHÈSE

Synthèse générale — L'essentiel du cours

Synthèse des chapitres de cette fiche · Repères essentiels avant les partiels

Idée centrale : communiquer dans les soins ne consiste pas uniquement à transmettre une information. Il faut **entrer en relation, comprendre la personne, adapter sa posture et vérifier le sens reçu**.

1. Comprendre la communication

- La communication est un **processus cognitif, social et affectif** ; parler ne suffit pas à garantir la compréhension.
- **Circuit :** émetteur → message → canal → récepteur → **feedback** (retour verbal ou non verbal).
- Le feedback permet de repérer une incompréhension et de **réajuster** le message ; un simple « oui » ne prouve pas que tout est compris.

2. Identifier les formes et les filtres

- **Verbal :** mots et vocabulaire ; **paraverbal :** ton, débit, volume, pauses ; **non verbal :** regard, mimiques, gestes et posture.
- Les **filtres** (émotions, expériences, croyances, culture, contexte) modifient le sens perçu.
- **Congruence :** les paroles, le ton et l'attitude doivent être cohérents.

3. Adapter à chaque personne soignée

- Commencer par identifier les **besoins, demandes, attentes et capacités** cognitives et sensorielles.
- Utiliser des mots accessibles, respecter le **temps de réponse**, reformuler et, si nécessaire, changer de canal (écrit, support visuel, etc.).
- Respecter les **choix et refus** ; préserver l'autonomie et rechercher la participation de la personne.

4. Adopter une posture aidante

- Être **disponible**, écouter activement, observer, accueillir les émotions et respecter les silences.
- Faire preuve d'**empathie** sans absorber les émotions d'autrui ; conserver une **juste distance**.
- Rester **authentique** : dire « je ne sais pas » plutôt qu'inventer, tenir ses engagements ; éviter ordres, jugements et promesses non fondées.

5. Tenir compte du cadre relationnel

- Préserver **confidentialité, intimité, confort et calme** : lieu, timing, position, bruits, interruptions, température.
- Prendre en compte l'**entourage** comme interlocuteur et ressource, sans effacer la parole de la personne soignée.
- Distinguer les relations de **civilité, de soin, empathique, d'aide, éducative et thérapeutique** selon leurs objectifs.

6. Raisonner en situation de soin

- **1. Décrire** les faits sans juger.
- **2. Identifier** le besoin, le filtre ou l'obstacle.
- **3. Hypothétiser** les effets possibles (sans les présenter comme certains).
- **4. Ajuster** le message, la posture ou le contexte.
- **5. Vérifier** l'effet par feedback et observation.

Fil conducteur à mémoriser : écouter et observer → comprendre le besoin → expliquer avec des mots adaptés → respecter les choix → vérifier la compréhension → réajuster. **En évaluation :** justifier une action soignante à partir des faits et de la situation, sans réponse automatique.

LEXIQUE

Définitions et mots-clés

Texte sélectionnable · définitions rédigées, utilisables pour les vocaux

Authenticité	Attitude sincère qui reconnaît ses limites, évite les réponses inventées et veille à tenir ses engagements.
Autonomie	Capacité de la personne à décider et à participer à ses activités selon ses possibilités.
Bientraitance	Démarche d'attention au respect, aux besoins et aux choix de la personne dans l'accompagnement.
Canal	Moyen utilisé pour transmettre un message, par exemple la voix, l'écriture ou un support visuel.
Communication	Processus cognitif, social et affectif par lequel des personnes échangent et interprètent informations, émotions ou intentions.
Communication adaptée	Communication ajustée aux besoins, capacités, attentes, émotions et circonstances du destinataire.
Communication non verbale	Communication reposant sur des signes non lexicaux tels que gestes, mimiques, regard, posture ou distance.
Communication paraverbale	Composantes vocales de la parole, notamment le ton, le débit, le volume, les pauses et l'intonation.
Communication verbale	Communication reposant sur les mots et leur signification.
Confidentialité	Exigence de protection des informations personnelles lors des échanges et dans leurs conditions matérielles.
Congruence	Cohérence entre les paroles et l'attitude, notamment le ton, les gestes et l'expression du visage.
Écoute active	Attitude attentive visant à comprendre l'expression, les émotions et les besoins d'une personne.
Émetteur	Personne à l'origine du message transmis par un canal.
Empathie	Capacité à comprendre le vécu et les émotions d'autrui sans les confondre avec ses propres émotions.
Feedback / rétroaction	Réaction d'un interlocuteur qui renseigne l'autre sur la réception et éventuellement la compréhension d'un message.
Filtre de communication	Facteur individuel, relationnel, social ou contextuel modifiant la perception ou l'interprétation d'un message.
Juste distance relationnelle	Positionnement adapté maintenant une présence aidante et les limites du cadre professionnel.
Mécanisme de défense	Modalité psychologique mobilisée pour faire face à une réalité ou une émotion difficile ; son interprétation ne se déduit pas d'un seul signe.

LEXIQUE

Définitions et mots-clés — suite

Suite et fin de la fiche

Message	Contenu adressé à un interlocuteur, avec son fond et sa forme.
Non-jugement	Attitude consistant à accueillir une personne sans la réduire à un préjugé ou à une interprétation hâtive.
Non-stigmatisation	Attitude refusant de réduire une personne à une caractéristique considérée négativement.
Objectivité	Fait de s'appuyer sur des éléments observables et de différencier constat et interprétation.
Parler	Utiliser des mots et des sons articulés pour exprimer une pensée ; cet acte ne garantit pas à lui seul un échange compris.
Préjugé	Jugement formé avant d'avoir une connaissance suffisante d'une personne ou d'une situation.
Prosodie	Organisation des variations de ton, de rythme et d'intonation qui participe au sens de la parole.
Proxémie	Gestion de la distance physique et de l'espace personnel dans une relation.
Récepteur	Personne qui reçoit et interprète le message à partir de ses capacités, de son contexte et de ses repères.
Reformulation	Action de reprendre avec d'autres mots pour clarifier un propos ou vérifier ce qui a été compris.
Relation de civilité	Échange fondé sur les règles de politesse et le respect de l'interlocuteur.
Relation de soin	Lien établi pendant la prise en charge, incluant accueil, information, actes et accompagnement.
Relation d'aide	Échange visant à accompagner une personne face à une difficulté, en soutenant ses ressources.
Relation éducative	Relation visant à renforcer la compréhension et les capacités nécessaires à une prise en soin.
Relation empathique	Relation dans laquelle le soignant cherche à comprendre le vécu émotionnel de l'autre.
Relation thérapeutique	Relation utilisée comme composante du soin dans un cadre et avec des objectifs définis.
Représentation	Interprétation ou idée personnelle qu'une personne se fait d'une situation ou d'un événement.